CAPÍTULO 143

TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS Y DRENAJE DE ABSCESOS

Belén García Marina | Rebeca Parada López

1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo tratamos el abordaje médico-quirúrgico de heridas y abscesos cutáneos que no impliquen afectación de estructuras (motoras o neurovasculares) ni situaciones de riesgo vital (arma de fuego, arma blanca, lesiones penetrantes en estructuras vitales o paciente politraumatizado).

2. TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS

2.1. ANAMNESIS

Incluye mecanismo lesional, tiempo de evolución, calendario vacunal, contexto lesional y tratamientos actuales.

Según el tiempo de evolución:

- Herida contaminada: > 6 h de evolución.
- Herida infectada: > 12 h de evolución.

Los antecedentes personales pueden ayudar a detectar grupos de riesgo de heridas tetanígenas que pueden modificar el manejo posterior: alto riesgo en trabajadores en contacto con tierra, aguas negras, animales domésticos o metales; usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP); diabéticos con mal control; puérperas (excepcional en nuestro medio), y > 50 años (mayor riesgo por implantación posterior del calendario vacunal).

2.2. EXPLORACIÓN DE LA LESIÓN

La inspección incluye: localización, tamaño, pérdida de sustancia, trayecto, profundidad, presencia de cuerpo extraño, inflamación o signos de infección.

Según su aspecto macroscópico, la herida puede ser:

- Limpia: de buen aspecto, con fondo sangrante sin cuerpos extraños ni necrosis.
- Sucia: cuerpos extraños o tejidos desvitalizados.

En cara y manos, se considerarán heridas contaminadas hasta pasadas 12-24 h para minimizar las secuelas funcionales y estéticas, dada su buena vascularización y menor riesgo de infección. No obstante, se recomienda que el cierre primario sea en las primeras 6 h para minimizar las secuelas estéticas. Serán heridas infectadas aquellas de > 24 h.

Debemos explorar los sistemas motor, vascular y nervioso (exploración incluida en el capítulo 142), poniendo especial atención en manos y pies, dado que vasos, nervios y tendones **(tabla 1)** están muy próximos a la superficie cutánea.

Tabla 1. Exploración tendinosa específica mano/pie

APARATO FLEXOR	• Flexor superficial • Flexor profundo	• Se explora sujetando todos los dedos menos el que queremos explorar y pidiendo al paciente que flexione el dedo • Se explora sujetando el dedo que queremos explorar por la falange proximal y pidiendo que flexione la falange distal
APARATO EXTENSOR		• Se indica al paciente que extienda cada uno de los dedos sujetando los anteriores
EMINENCIA TENAR	• Abductor corto y flexor corto • Oponente del pulgar • Aductor del pulgar	• Se explora flexionando la articulación interfalángica del primer dedo por delante de la palma • Se explora aproximando el primer dedo hacia la metacarpofalángica del 5.º dedo • Se explora separando el primer dedo
EMINENCIA HIPOTENAR	• Cutáneo palmar • Aductor del 5.º dedo • Flexor corto • Oponente	• Contrae la piel de la eminencia hipotenar • Se explora flexionando la primera falange y llevándola hacia adelante • Se explora flexionando la primera falange • Se explora desplazando el 5.º dedo hacia adelante y hacia fuera

2.3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

No están indicadas de forma generalizada. Ante sospecha de fractura o presencia de cuerpos extraños se recomienda estudio radiológico simple. Ante sospecha de cuerpos extraños radiopacos la radiología simple es la prueba de elección. Hay que valorar la ecografía ante sospecha de cuerpos extraños de madera, plástico, vidrio o espinas vegetales.

En heridas sucias/infectadas que presenten afectación cutánea perilesional se seguirán las recomendaciones del capítulo sobre infecciones de piel y partes blandas.

2.4. TRATAMIENTO Y RECOMENDACIONES

El tratamiento de las heridas irá encaminado siempre a restablecer su solución de continuidad, así como a detectar las heridas tetanígenas y las que precisan tratamiento antibiótico empírico **(tablas 2 y 3)**

Tabla 2. Tratamiento de las heridas según aspecto y tiempo de evolución

HERIDA LIMPIA Y ATENDIDA < 6 h	Cierre primario	No antibioterapia
HERIDA SUCIA O ATENDIDA EN 6-12 h (CONTAMINADA)	Friedrich* Cierre primario +/- drenaje	Antibioterapia v.o.
HERIDA SUPURANTE O ATENDIDA > 12 h (INFECTADA)	Cierre secundario	Antibiótico v.o. + curas antisépticas locales

* Técnica de eliminación del tejido esfacelado o necrótico de una lesión por medios quirúrgicos o médicos.

Notas:

- En cara y manos hay que considerar 12-24 h para herida contaminada y > 24 h para infectada.
- La mucosa oral no precisa antibioterapia empírica excepto si hay cuerpo extraño.
- Las heridas por mordedura se consideran infectadas excepto en zonas de importancia estética, donde se puede valorar una sutura de aproximación.

Tabla 3. Indicaciones de la vacunación antitetánica

ANTECEDENTES DE VACUNACIÓN	HERIDA LIMPIA		HERIDA TETANÍGENA*	
	Vacuna	IGT	Vacuna	IGT
< 3 dosis o desconocida	Sí (completar primovacunación)	No	Sí (completar primovacunación)	Sí
3 o 4 dosis	No (si hace más de 10 años de la última dosis, administrar una dosis)	No	No (si hace más de 5 años de la última dosis, administrar una dosis)	No
5 o más dosis	No	No	No (si hace más de 10 años de la última dosis, administrar una dosis)	No

* Heridas con un importante grado de desvitalización, heridas punzantes en contacto con suelo o estiércol, heridas con cuerpos extraños, fracturas abiertas, quemaduras, mordeduras, heridas por congelación, aquellas que requieran intervención quirúrgica, aquellas con más de 6 h de evolución y aquellas que se dan en pacientes incluidos en grupos de riesgo.

IGT: inmunogammaglobulina antitetánica.

2.4.1. Equipamiento y material necesario

La sala constará al menos de: camilla de intervención, mesa para instrumental, fuente de luz dirigible, silla sin respaldo, lavabo con grifo monomando y aplicador automático de jabón para un correcto lavado de manos.

El set básico debe incluir: bisturí, tijeras, pinzas de disección, portaagujas, guantes (no obligatoriamente estériles), gasas, paño estéril y material propio para la realización de sutura. Se seleccionará la sutura **(tabla 4)** según las características de la lesión:

Tabla 4. Tipo de sutura recomendado según la localización de la herida

REGIÓN	TIPO DE SUTURA	CALIBRE	RETIRADA
Cara	Seda/monofilamento	5/0	5-7 días
Cuello	Seda/monofilamento	4/0-5/0	7-10 días
Cuello cabelludo	Seda/grapas	2/0-3/0	7-10 días
Manos	Seda/monofilamento	3/0-4/0	10-14 días
Dedos	Seda/monofilamento	4/0-5/0	10-14 días
Tronco y espalda	Seda/monofilamento	2/0-3/0	7-10 días 10-14 días
Miembro superior/inferior	Seda/monofilamento	3/0-4/0	7-10 días
Mucosa	Reabsorbible	3/0-4/0	no se retira

- Adhesivos tisulares (cianoacrilato): por contacto. En líquido o en puntos de sutura adhesivos (aproximación). Presentan similares resultados en lesiones muy superficiales cortas, en áreas de baja tensión, con bordes aproximados congruentes y sin pérdida de sustancia. No precisan retirada. La combinación de ambos ofrece mejores resultados estéticos.
- Grapas: mayor secuela estética, con aplicación más rápida y menos dolorosa. No precisan anestesia local. Se usan en zonas poco expuestas y cuero cabelludo.
- Hilos de sutura:
  - Origen: natural (seda, lino, catgut) o sintético (nailon/poliamida, polipropileno, poliglactina 910, poliéster).
  - Calibre: n.º de 0: a mayor n.º de 0, menor calibre.
  - Tiempo de permanencia: no reabsorbibles (deben ser retirados y se usan para suturas superficiales). Reabsorbibles: no precisan retirada. Indicados en planos más profundos (dermis y tejido celular s.c.) o mucosas. Zonas de baja tensión.
  - Acabado industrial:
    - Monofilamentos: coeficientes de fricción bajo (traumatiza poco los tejidos). Capilaridad muy baja (dificulta la colonización por bacterias).
    - Multifilamentos: más flexibles, manejables y resistentes que el monofilamento. Coeficiente de fricción y capilaridad mayores que los del monofilamento.

Los tipos de agujas son:

- Cilíndricas: para tejidos blandos y fascias, pero no para la piel.
- Triangulares: para suturar la piel.

2.4.2. Higiene quirúrgica

Se realizará un lavado con tracción de la zona que se va a tratar. Hay que valorar el rasurado, aunque esta técnica está cada vez menos recomendada y en ningún caso se recomienda rasurar las cejas porque supondría una pérdida de referencia anatómica y puede acarrear problemas estéticos. Por último realizaremos desinfección con clorhexidina al 2 %.

2.4.3. Anestesia tópica local y bloqueo regional

Los anestésicos locales son agentes farmacológicos que interrumpen la conducción nerviosa de forma transitoria y con posterior recuperación completa de la sensibilidad de la zona. Se pueden aplicar de las siguientes maneras:

- Anestesia tópica: se puede valorar en intervenciones muy superficiales o población pediátrica (lidocaína 25/prilocaína 25 mg). Se aplican 1-2 g de crema/10 cm^2 de superficie cutánea y afecta a un máximo de 5 mm de profundidad. Se debe cubrir con un apósito oclusivo. Dura 2 h. Está contraindicada en heridas abiertas, < 6 meses o alergia a alguno de sus componentes.
- Anestesia por infiltración: los anestésicos más usados en nuestro medio son la lidocaína al 2 % y la mepivacaína (al 1 o 2 %, con/sin vasoconstrictor). La dosis máxima para la mepivacaína al 2 % es de 20 ml/día (400 mg) o de 7 mg/kg/1,5 h para la infiltración y de 2-4 ml (40-80 mg) para la anestesia troncular. Se desinfectará la zona que se va a infiltrar y posteriormente se punciona con aguja fina inclinada 45º realizando un habón dérmico con 0,5-1 ml e introduciendo el anestésico por toda la superficie en retirada. Se aspirará previamente para comprobar que no estamos en el lecho vascular. Hay que valorar anestésico tópico previa infiltración. Existen diferentes técnicas **(figuras 1-3)**.
- Bloqueo regional: la anestesia troncular precisa menor cantidad de anestésico para infiltrar zonas amplias y presenta una mayor duración del efecto anestésico. Por el contrario, existe la posibilidad de producir daño neural directo o inyección intravascular, por lo que se recomienda

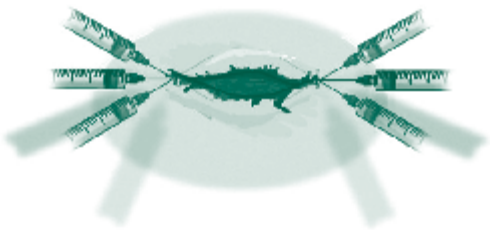

Figura 1. Infiltración en abanico.

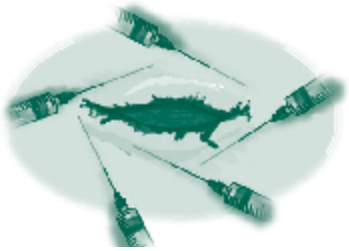

Figura 2. Infiltración perilesional.

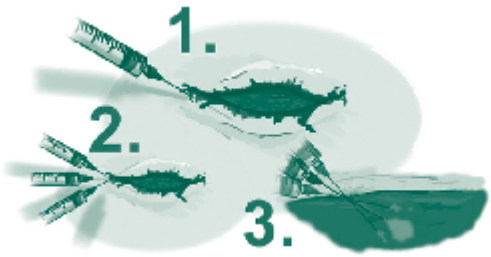

Figura 3. Infiltración angular en una sola punción.

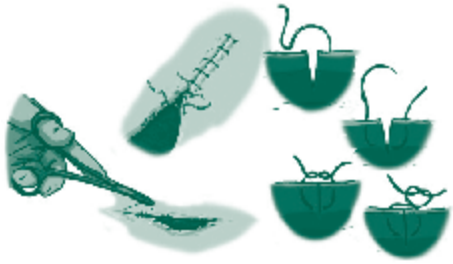

Figura 4. Punto simple.

siempre anestésico sin vasoconstrictor. El inicio del efecto anestésico es más lento, 10-15 min. En los bloqueos digitales, con la palma apoyada en la mesa quirúrgica, con una aguja s.c., se inyectará perpendicularmente al eje longitudinal del dedo a la altura de la base de la falange proximal, lateral a la superficie ósea y perpendicular a la mesa, en ambas caras laterales, 1 ml del anestésico elegido (lidocaína al 2 % o mepivacaína al 2 %).

2.5. SUTURA

Tras la anestesia y la preparación del material necesario se procede a la sutura de la herida. Se realizarán siempre el menor número de puntos posibles para conseguir hemostasia y buen resultado estético. Se exponen a continuación los diferentes tipos:

- Punto simple **(figura 4)**: se enfrentan ambos bordes tras su eversión, se pasa el hilo primero por un borde y posteriormente por el otro y se cierra con varios nudos hechos en diferentes sentidos de manera alternante y dejando todos los nudos al mismo lado de la herida.
- Punto colchonero vertical **(figura 5)**: es uno de los más hemostáticos. Se pasa el hilo por un borde, posteriormente por el otro y de manera perpendicular acercándonos a la herida se vuelve hasta unir los dos cabos.
- Punto colchonero horizontal **(figura 6)**: está indicado en zonas de importante tensión cutánea. Se pasa el hilo por un borde, posteriormente por el otro y de manera paralela acercándonos a la herida se vuelve hasta unir los dos cabos.
- Punto intradérmico o punto simple invertido: se realizará con sutura reabsorbible en las mucosas y para suturar en los planos internos.
- Sutura intradérmica: tiene muy buen resultado estético, pero poca resistencia a la tensión.

Figura 5. Punto colchonero vertical.

Figura 6. Punto colchonero horizontal.

2.6. CUIDADOS Y RECOMENDACIONES AL ALTA

- Valorar la analgesia oral.
- Retirar la sutura en Enfermería de Atención Primaria previa cita.
- No humedecer las primeras 24 h y posteriormente hacer lavados diarios con agua y jabón.
- En zonas fotoexpuestas, después de la cicatrización, aplicación de protección solar.
- Revisar las heridas a las 72 h en Centro de Salud.
- Explicar los síntomas de posibles complicaciones.
- Completar la vacunación antitetánica si está indicada **(tabla 3)**.

2.7. COMPLICACIONES Y SECUELAS

- Sangrado lesional: se previene con buena hemostasia y sutura más profunda; se trata con la colocación de un vendaje compresivo.
- Hematoma/seroma: se previene suturando por planos. El tratamiento es la evacuación, realizada a través de la herida, o retirando algún punto; si es pequeño se puede reabsorber de forma espontánea.
- Infección: se previene con una correcta asepsia y antibioterapia empírica si está indicada. Se trata con drenaje de material purulento y antibioterapia. La infección por *Clostridium tetani* es muy infrecuente en nuestro medio. Presenta una clínica de fiebre con espasmos musculares, trismo y parálisis por rigidez de musculatura abdominal, respiratoria y deglutoria. Es importante su prevención con vacunación e IGT según las indicaciones anteriormente descritas (tabla 3).
- Dehiscencia de sutura: la dehiscencia reciente (antes de 12 h) se puede volver a suturar; en caso contrario se dejará cicatrizar por segunda intención y se valorará añadir antibioterapia empírica v.o.
- Cicatriz hipertrófica/queloide: en pacientes con antecedentes hay que optimizar la técnica (sutura intradérmica o aplicación de apósitos de silicona). Es conveniente derivar a un Servicio de Cirugía Plástica/Dermatología todas las intervenciones no urgentes en pacientes que presentan este tipo de patología.
- Pigmentación anómala de la cicatriz: más frecuente en zonas fotoexpuestas, se debe aplicar fotoprotección alta.

3. TRATAMIENTO DE LOS ABSCESOS CUTÁNEOS

Un absceso cutáneo es el acúmulo de material purulento en la dermis o en el tejido celular s.c. que se manifiesta como una masa edematosa, hiperémica, fluctuante y muy dolorosa, con presencia de signos inflamatorios locales. Los gérmenes más frecuentes que lo producen son: *Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus aureus* (baja incidencia de *Staphylococcus aureus* meticilín-resistente [SARM] en nuestro medio). Resulta muy rara la afectación polimicrobiana.

3.1. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- Celulitis: placas eritematosas, calientes, edematosas y de bordes difusos que no delimitan bien la piel enferma de la sana. Sin fluctuación, puede acompañarse de fiebre y malestar general.
- Erisipela: placa edematosa, de color rojo brillante, con aspecto de piel de naranja, dolorosa y caliente al tacto, sobreelevada y con un borde que la delimita claramente de la piel sana, puede asociar fiebre.
- Piomiositis: afectación de capas profundas de la piel (muscular), más frecuente en pacientes inmunodeprimidos.
- Infecciones necrotizantes: fascitis necrotizante de los tipos 1 y 2. La tipo 1 normalmente es producida por flora mixta anaerobia y resulta más frecuente en inmunodeprimidos, mientras que la tipo 2 es producida por *Streptococcus* del grupo A, muy grave y de rápida evolución, por lo que siempre está indicado el drenaje en quirófano.

3.2. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

No están indicadas en la mayoría de casos. Sin embargo, se debe prestar especial atención ante:

- Afectación sistémica: fiebre, deterioro del estado general y criterios qSOFA (Glasgow, frecuencia respiratoria, tensión arterial sistólica < 100 mmHg): analítica completa con bioquímica, hemograma y coagulación.
- Celulitis perilesional importante (manejo según el capítulo 103): en caso de duda diagnóstica la prueba de elección es la ecografía de partes blandas.
- Localización:
  - Cuello: realizar radiografía/ecografía de partes blandas con el objetivo de descartar la posible afectación de estructuras vecinas.
  - Mama: posibilidad de asociación a neoplasia subyacente; se realizará una ecografía.
  - Perianal: ante la duda diagnóstica se valorará la realización de una tomografía computarizada (TC).
- Implicación de drenaje en el quirófano (por tamaño o localización): preoperatorio completo.
- Sospecha de bacterias resistentes o SARM: siempre cultivo.

3.3. TRATAMIENTO

Debe ser siempre el drenaje quirúrgico, en Urgencias o en quirófano, según localización (como el absceso perianal) y tamaño. No está indicada la administración de antibióticos v.o. con el objetivo de “reducirlo” o curarlo.

3.3.1. Técnica de drenaje

1. Asepsia y antisepsia de la zona con clorhexidina al 2 %. Aplicación en círculos concéntricos de dentro a fuera.
2. Aplicación de anestesia local perilesional (siempre en piel sana). En abscesos muy avanzados puede no ser efectiva. Dado que se trata de un proceso muy doloroso para el paciente, se podría valorar la sedación superficial.
3. Incisión: se pueden valorar dos técnicas:
   - Incisión clásica: amplia, en la zona de mayor fluctuación, de manera que se permita la salida del material purulento y el desbridamiento posterior de la cavidad con un mosquito; una incisión insuficiente puede provocar el cierre precoz y una nueva abscesificación.
   - Drenaje en bucle (*loop*) **(figura 7)**: realización de dos incisiones pequeñas en los laterales del absceso y paso de un drenaje que va anudado en el exterior en bucle. Esta técnica ha demostrado que disminuye el dolor del procedimiento y las secuelas estéticas. Es al menos tan eficaz como la incisión clásica.

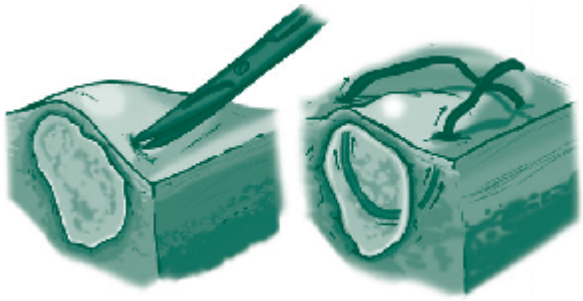

Figura 7. Drenaje en bucle (*loop*).

En ningún caso está recomendada la aspiración con aguja fina como sustitución de la incisión.

4. La irrigación de la cavidad no está recomendada ya que aumenta el dolor y no ha demostrado que mejore en ningún aspecto la curación.
5. Colocación de drenaje: en incisión simple, drenaje con gasa, Penrose o tipo teja. Si se trata de la técnica en bucle, drenaje tipo *loop* o un dedo de guante estéril. El uso del *packing* (relleno de la cavidad con gasa y drenaje) es controvertido.
6. Cura oclusiva.

3.3.2. Antibioterapia

No está indicada la antibioterapia empírica v.o. de forma generalizada tras el drenaje del absceso, excepto si hay importante celulitis circundante, múltiples abscesos, signos de afectación sistémica, diabetes *mellitus* (DM) con mal control o inmunodeprimidos o riesgo de infección por SARM.

3.4. MANEJO POSTERIOR

Hay que retirar la cura oclusiva a las 24 h y mantener el drenaje mientras haya débito.

En casos especiales se valorará la derivación a la consulta de referencia (abscesos en la mama o cervical, abscesos de repetición, quistes sebáceos o hidrosadenitis).